جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : دولات حسين صادق حمد
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** البدرشين **العنوان :** مممممممممممممم
رقم البطاقة : 28303032302686 **رقم التليفون :** 01129088314 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 21-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 03-03-1983 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي الصدر والبطن والحوض بالصبغه [11129] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: دولات حسين صادق حمد
National ID: 28303032302686

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest, abdomen, and pelvis

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient Name	: الأستاذه / دولات حسين عبدالصادق حمد	Request No.	: 13001325
Patient No.	: 28303032302686	Request Date	: 18/06/2022
Path No.	: SR-434/22	Verification Date	: 29/06/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 39 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

Clinical Data:
Left interprectoral malignant looking lesion with history of left breast MRM for IDC,grade III.

Nature of the specimen:
Slides revision

Gross Examination:
One parrafin block labeled as (2156/20), three slides, thirteen parrafin block labeled as (521/21) and one parrafin block labeled as (4834/22) were recieved.

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): grade III (3+2+3)

-IPT :
ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)
PR: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)
Her-2: No membrane reaction in tumour cells. Negative, (score 0)

Diagnosis:
Left interprectoral mass, Slide revision:
-Invasive duct carcinoma, grade III.
- IPT :
- ER: Negative (score 0/8).
- PR: Negative (score 0/8).
- HER-2: Negative (score 0).

Prof.Dr. Gamal Abdelaty
Dr. Menna Nabil.

Verified by :
DR.Menna Nabil

قطعة رقم (6) - الدور الأول - مبنى رقم (237) - الشارع الثاني - بحي الهضبة - القاهرة - مصر
Room No. (6) - First Floor-Building No. 237- 2nd Corniche - Nile El Qadema- Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name: دولات حسين عبد الصادق حمد **MR. :** 5603	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

CTB scan performed on 3/1/26 demonstrated a hepatic focal lesion (HFL) that was non-enhancing, pending further correlation.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : حنان عزت شفيق تاودروس

يعتمد ,

PATIENT NAME: **DAWLAT HUSEN ABD EL SADEK HAMAD** GENDER: **Female** AGE: **39 y**	PATIENT ID #: **2020126478** ORDER #: **1655239,1655240** DATE OF SERVICE: **07-Jun-2022 03:54 PM**

Report: - all studies

Multislice post contrast CT scan of the chest, abdomen and pelvis revealed:

(I) Chest:

- Status post left mastectomy with no sizable operative bed masses or collections seen.
- A large left interpectoral lymph node is seen measuring about 2.2 x 1.9 cm in its maximum axial dimensions.
- Few tiny left pulmonary nodules are seen measuring up to 3 mm maximally
- A right lower lobe calcified nodule is seen , likely post old granulomatous..
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node pathological enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density and enhancement with a segment III hypodense hepatic focal lesion measuring about 13 x 10 cm with no contrast enhancement as well as another tiny one in segment II. No other focal lesions.
- Patent and homogenously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- Left adenexal cyst is seen measuring about 2.9 x 2.4 cm in its maximum axial dimensions, likely functional cyst.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient name: Dawlat Hussein

Date: 6/5/2021

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had left MRM, on 1/2021

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- Right breast is heterogeneously dense, which may obscure small lesions (ACR C)
- Typically benign diffuse punctate calcifications, with no suspicious grouping
- No speculated masses or suspicious micro calcific clusters of the right breast.
- Complementary ultrasound showed right breast circumscribed oval shaped hypoechoic mass, seen at 10 o'clock, measured 4x9mm.
- Normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- right breast 10 o'clock probably benign lesion, for follow up after 3 months (BIRADS 3)

Yours truly

Dr Mai Magdy

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]